

Branchenvertiefung Heilberufe

Arztpraxen, Apotheken und Heilberufe als Firmenkundensegment

Ärzte, Zahnärzte und Apotheker sind gefragte Kunden – aber KV-Abrechnung, Goodwill und Praxisübernahme folgen eigenen Regeln. Sie arbeiten die Besonderheiten der Heilberufe durch und rechnen eine Praxisübernahme-Finanzierung vollständig durch. Danach beraten Sie Heilberufler fachkundig und beurteilen Übernahmefinanzierungen sicher.

KOMPETENZFELD
K-02 Branchenwissen

KOMPETENZSTUFE
Sparringspartner

DAUER
ca. 4–4,5 Stunden

VERSION
v1.0

Ablaufplan Halbtage (230 Minuten Nettozeit zzgl. 20 Minuten Pausen | 09:00–13:10 Uhr)

Hinweis zur Zeitplanung: Die drei Theorie-Inputs sind bewusst mit Puffer für ein realistisches Rückfragevolumen kalkuliert (gemischte Gruppen mit Experten- und Grundlagenfragen). Wer eine homogen erfahrene Gruppe vor sich hat, kann die Inputs um je 5 Minuten kürzen und früher enden.

Uhrzeit	Dauer	Phase	Inhalt	Methode	Material
09:00	15 min	Einstieg	Begrüßung, Blitzlicht-Runde: „Welchen Heilberufe-Kunden haben Sie heute im Bestand – Arzt, Zahnarzt, Apotheker, Therapeut?“ Tagesüberblick, Lernziele	Plenum, Blitzlicht	Flipchart
09:15	35 min	Theorie-Input 1	Freie Berufe §18 EStG: Abgrenzung Freier Beruf / Gewerbebetrieb; EÜR vs. Bilanz – Besonderheiten und Fallen; DSC R-Berechnung aus EÜR	Trainer-Vortrag mit Visualisierung	Folie T-1, Vergleichstabelle
09:50	20 min	Gruppenarbeit 1	EÜR-Fallen-Analyse: Drei anonymisierte EÜR-Auszüge – Gruppen identifizieren je zwei typische Analysefallen und begründen ihre Einschätzung	Kleingruppen (3–4 TN)	AB-K01 (EÜR-Karten)
10:10	10 min	Pause 1	Kaffeepause		
10:20	35 min	Theorie-Input 2	Praxisbewertung nach IDW S5: Substanzwert, Goodwill-Berechnung modifizierte Ertragswertmethode, Finanzierungsstruktur, Investitionsanlässe	Trainer-Vortrag mit Rechenbeispiel	Folie T-2, Taschenrechner

Uhrzeit	Dauer	Phase	Inhalt	Methode	Material
10:55	30 min	Rechenübung	Fallbeispiel „Dr. Müller“: Goodwill-Berechnung nach IDW S5 mit gegebenen Daten (Ø-Jahres überschuss, Unternehmerlohn, Risikoabschlag, Kapitalisierungsfaktor)	Einzelarbeit, dann Besprechung	AB aus Sec 4, Taschenrechner
11:25	10 min	Pause 2	Kurzpause (Lüften, Bewegung)		
11:35	20 min	Theorie-Input 3	Risikoprofil Heilberufe: Zulassungsrisiken, Regressrisiken, Inhaberabhängigkeit, Konsolidierungsrisiko (MVZ). Sicherheitenkonzept: was beleihbar ist, was nicht	Trainer-Vortrag	Folie T-3
11:55	40 min	Hauptfall	Fallstudie aus Sec 4: vollständige Analyse und Kreditempfehlung (Berechnung DSCR + Goodwill, Risikoklassifizierung, Sicherheitenstruktur, Verbundpartner)	Kleingruppenarbeit (3–4 TN)	Fallunterlagen Sec 4
12:35	15 min	Präsentation	Gruppen präsentieren Ergebnisse (max. 3 Minuten je Gruppe), Trainer moderiert Diskussion	Plenum	Flipchart
12:50	10 min	Wissenstest + Transfer	Wissenstest L2 (Sec 6) – Einzelarbeit; anschließend Transferplanung: „Was setze ich morgen konkret um?“	Einzelarbeit	Testbogen Sec 6, Transferbogen Sec 5

Uhrzeit	Dauer	Phase	Inhalt	Methode	Material
13:00	10 min	Abschluss	Feedbackbogen L1 ausfüllen, Blitzlicht-Abschlussrunde, Verabschiedung	Plenum	Feedbackbogen Sec 6
13:10	Ende				

Moderationshinweise

Einstieg (09:00–09:15)

Die Blitzlicht-Frage aktiviert Vorwissen und zeigt dem Trainer, wie divers der Heilberufe-Bestand der TN ist. Wichtig: alle Antworten gleichwertig würdigen. Wenn jemand sagt „Ich habe noch keinen Heilberufe-Kunden“, diesen TN als besonders lernmotiviert einrahmen – er kann im Modul Muster für künftige Kunden aufbauen.

Theorie-Input 1: EÜR-Besonderheiten

Häufiger Fehler: TN glauben, die EÜR sei weniger informativ als eine Bilanz – deshalb schwerer zu analysieren. Korrektur: Die EÜR ist anders, nicht schlechter. Zufluss-/Abflussprinzip ist verständlich, wenn man konkret fragt: „Wann zahlt die KV aus?“ Die Antwort (6–10 Wochen nach Quartalsende) macht die Liquiditätslücke sofort greifbar.

Gruppenarbeit 1: EÜR-Fallen-Analyse (AB-K01)

Die drei laminierten EÜR-Auszüge enthalten je mindestens zwei eingebaute Analysefallen. Damit Sie die Plenumsdiskussion sicher steuern und – je nach Vorerfahrung der Gruppe – differenziert nachsteuern können, hier die erwartete Musterlösung:

Trainer-Hinweis AB-K01 – Erwartete Analysefallen:

EÜR-Auszug 1 (Hausarzt, GKV-lastig):

– *Falle A (mittel): KV-Abrechnungsspitze im Dezember → Zufluss-/Abflussprinzip, kein nachhaltiges Jahreseinnahmen-Signal. Frage an die Gruppe: „Steht der Dezember-Betrag auch im nächsten Jahr drin?“*

– *Falle B (leicht): Privatentnahmen und Privatsteuern fehlen in der EÜR → freier Cashflow / DSCR nicht berechenbar ohne Steuerbescheid.*

EÜR-Auszug 2 (Zahnarzt, PKV-lastig):

– *Falle A (schwer): Investitionszuschuss in den Betriebseinnahmen → nicht nachhaltig, aus der DSCR-Basis herausrechnen. Diese Falle eignet sich zur Differenzierung erfahrener TN.*

– *Falle B (mittel): Hoher PKV-Anteil → Klumpenrisiko, wenn wenige Privatpatienten abwandern.*

EÜR-Auszug 3 (Apotheke):

– *Falle A (mittel): Hoher Wareneinsatz bei niedriger Marge (Fixzuschlag 8,35 EUR/Packung) → Rohertrag statt Umsatz betrachten.*

– *Falle B (leicht): Warenlager-Aufbau als Einmalausgabe → verzerrt das Ergebnisjahr, kein dauerhafter Aufwand.*

Differenzierung: Erfahrene TN (z. B. mit eigener Praxisfinanzierungs-Erfahrung) gezielt auf die schweren Fallen (Investitionszuschuss, Rohertrag) ansetzen; Einsteiger zunächst die leichten Fallen (fehlende Privatentnahmen, Warenlager) finden lassen.

Rechenübung: IDW S5 Goodwill-Berechnung

Taschenrechner sind Pflicht. Vor Beginn die fünf Rechenschritte des IDW-S5-Schemas an die Flipchart schreiben (Folie T-2). TN mit unterschiedlichem Rechentempo: Schnelle TN berechnen Variante mit höherem Kapitalisierungsfaktor; langsame TN besprechen Zwischenergebnis mit Nachbarn.

Häufiger Fehler: Unternehmerlohn wird nicht von Jahresüberschuss abgezogen – darauf explizit hinweisen, da in EÜR-Daten nicht automatisch sichtbar.

Hauptfall: Kleingruppenarbeit

Nach 20 Minuten aktiver Check: Haben alle Gruppen die DSCR-Berechnung abgeschlossen? Falls nicht, kurzen Hinweis zu Formelkarte geben. Die Präsentation soll nicht die Zahl, sondern die Argumentation zeigen: „Warum empfehlen Sie dieses Sicherheitenkonzept?“

Typische Reaktion der TN beim Goodwill-Gap (390 TEUR rechnerisch vs. 220 TEUR Kaufpreis): „Der Verkäufer verschenkt ja fast die Hälfte – das klingt zu gut, um wahr zu sein.“ Das ist ein gesunder Instinkt – und genau der richtige Ausgangspunkt. Statt die Differenz akademisch wegzuerklären, mit der Folgefrage weiterarbeiten: „Was würde Sie als erfahrener Berater dazu bringen, dennoch vorsichtig zu sein?“ Dann entstehen erfahrungsgemäß die besten Diskussionen zu Informationsasymmetrie und Due Diligence – ohne dass das Fachvokabular fallen muss.

Brücke zur wissenschaftlichen Einordnung (Sec 2): Wenn TN fragen, warum ein Verkäufer weit unter Gutachterwert verkauft, ist das der Moment, den Begriff **Informationsasymmetrie** einzuführen – ohne Fachvokabular-Zwang. Denkfrage in die Gruppe: „Was wissen Sie als Käufer nicht, was der Verkäufer weiß? Das ist die entscheidende Frage bei jedem Unternehmenskauf.“ Die wissenschaftliche Fundierung (Stiglitz & Weiss, 1981^{Q171}) können Sie im Nachgang als Literaturhinweis nennen – in der Gruppendiskussion reicht die Denkfrage. So wird die abstrakte Theorie aus Sec 2 für die TN an einem konkreten, emotional aufgeladenen Fallmoment greifbar.

Häufige Teilnehmerfragen und Trainerantworten

F1: „Warum müssen wir den Unternehmerlohn beim IDW S5 abziehen? Der Arzt lebt doch von dem Geld.“

Antwort: Genau – das ist der Punkt. Der Goodwill bewertet den Wert der Praxis für einen neuen Inhaber. Der neue Inhaber muss sich selbst bezahlen (Unternehmerlohn für Vollzeiteinsatz als Arzt). Dieser Lohn ist Kosten, kein Ertrag. Nur was nach diesem Eigenanteil übrig bleibt, ist der nachhaltige Praxisüberschuss, den ein Käufer wirklich erzielen kann. Ohne diesen Abzug würde man eine Einzelperson-Praxis wie ein anonymes Unternehmen bewerten – das wäre falsch.

F2: „Was passiert mit dem Goodwill-Kredit, wenn der Arzt nach Übernahme stirbt oder krank wird?“

Antwort: Das ist das zentrale Risikoargument bei der Goodwill-Finanzierung. Der Goodwill erlischt mit der Person – er ist nicht auf einen Dritten übertragbar. Deshalb: Risikolebensversicherung des neuen Inhabers in Höhe des Kreditvolumens als Sicherheit, abgetreten an die Bank. Das ist kein optionales Komfortmittel, sondern bei Goodwill-Finanzierungen Standard. Im Gespräch mit dem Kunden: „Ohne Risikolebensversicherung können wir den Goodwill-Anteil nicht finanzieren.“

F3: „Was ist der Unterschied zwischen dem Versorgungswerk und der gesetzlichen Rentenversicherung – warum ist das kreditrelevant?“

Antwort: Heilberufe-Angehörige (Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte) sind nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert, sondern in berufsständischen Versorgungswerken. Das bedeutet: Sie erwerben keine DRV-Rentenansprüche. Das Versorgungswerk-Kapital ist bei der Beurteilung der Altersvorsorge zu berücksichtigen – und es ist oft erheblich. Für die Kreditanalyse: Im Ruhestand fällt das Versorgungswerk-Einkommen an Stelle von GKV/Praxiseinkommen. Für die Beratung: Wer den Erlös aus der Praxisabgabe anlegt, baut eine zweite Einkommensschicht auf.

F4: „Apotheken sind doch alle gleich – warum müssen wir die so genau analysieren?“

Antwort: Scheinbar ja. In Wirklichkeit unterscheidet sich eine Apotheke mit starkem OTC-Anteil und Stammkundschaft grundlegend von einer Klinik-Apotheke oder einer reinen Rezeptapotheke. Außerdem: Das AMNOG schränkt die Margen bei Hochpreispräparaten ein, die Fixpreisstruktur (8,35 EUR/Packung) bei GKV-Arzneimitteln lässt wenig Spielraum für Differenzierung. Apotheken mit besonderer Nischenkompetenz (Palliativversorgung, Zytostatika, Heimversorgung) haben ein völlig anderes Risiko- und Ertragsprofil als Standard-Offizin-Apotheken.

F5: „Kann ich einem Kunden empfehlen, eine Arztpraxis zu kaufen, wenn ich den Wert nicht selbst berechnen kann?“

Antwort: Ja – aber nur mit externer IDW-S5-Bewertung. Als FK-Berater sind Sie kein Unternehmensgutachter. Ihre Rolle ist: den Bewertungsrahmen kennen, den Kunden auf die Notwendigkeit einer Gutachtenbeauftragung hinweisen, das Gutachtenergebnis plausibilisieren (Bandbreiten, Kapitalisierungsfaktor, Substanzwertanteil) und die Finanzierungsstruktur auf dieser Basis konstruieren. Wer das Gutachten gar nicht versteht, kann keine sinnvolle Finanzierungsstruktur ableiten – das ist der Grund, warum IDW S5 hier gelernt wird.

Materialliste

- Taschenrechner (1 pro TN, zwingend)
- Ausgedruckte Fallunterlagen Sec 4 (1 Satz pro TN)
- AB-K01: 3 anonymisierte EÜR-Auszüge für Gruppenarbeit (laminiert, wiederverwendbar)
- Formelkarte DSCR + IDW S5 (1 Laminat pro TN)
- Feedbackbogen L1 (1 pro TN)
- Wissenstest L2 (1 pro TN; Musterlösung erst nach Abgabe ausgeben)
- Beobachtungsbogen L3 (1 pro TN / für Führungskraft)
- Flipchart + Marker; Beamer oder Präsentationsfolien T-1 bis T-3

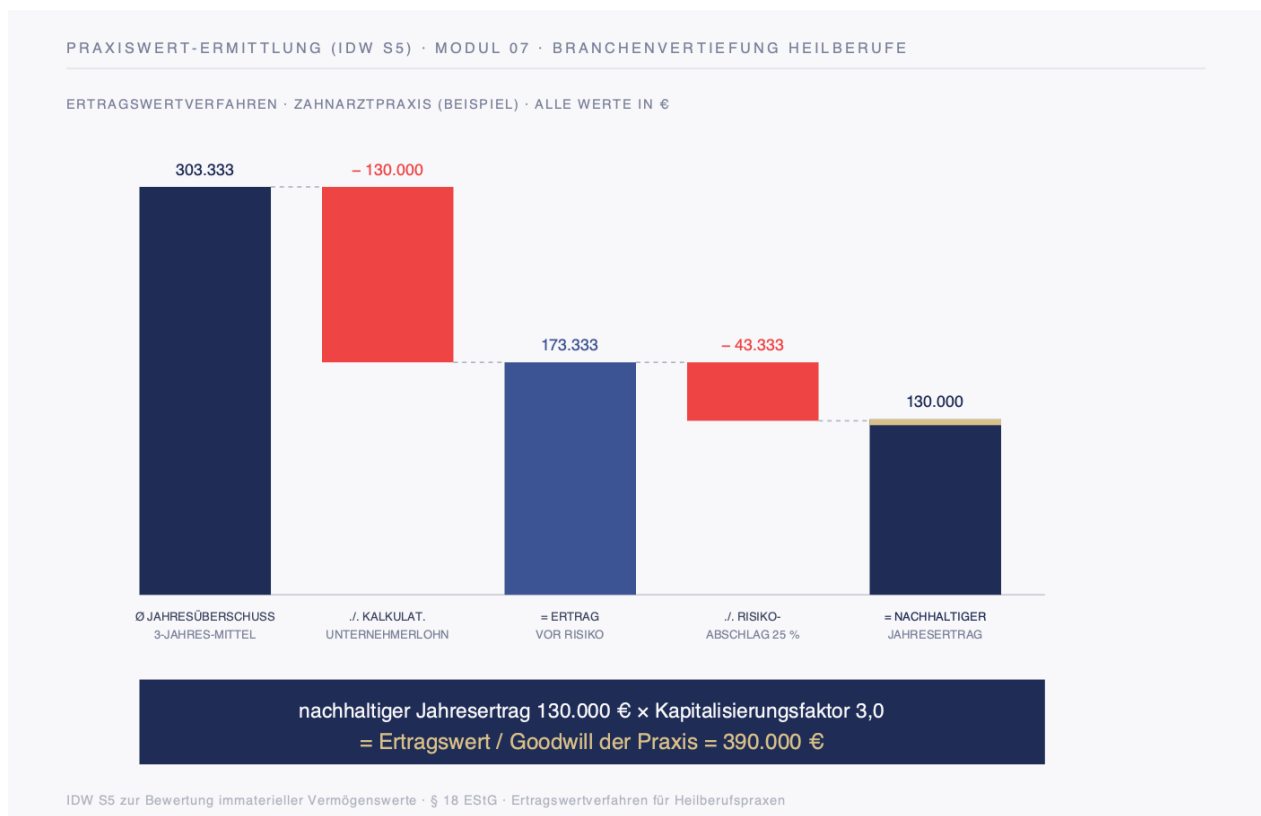
Trainer-Checkliste vor dem Seminar

Nr.	Aufgabe	erledigt
1	Teilnehmerliste erhalten, Vorwissenstand M06 geprüft	

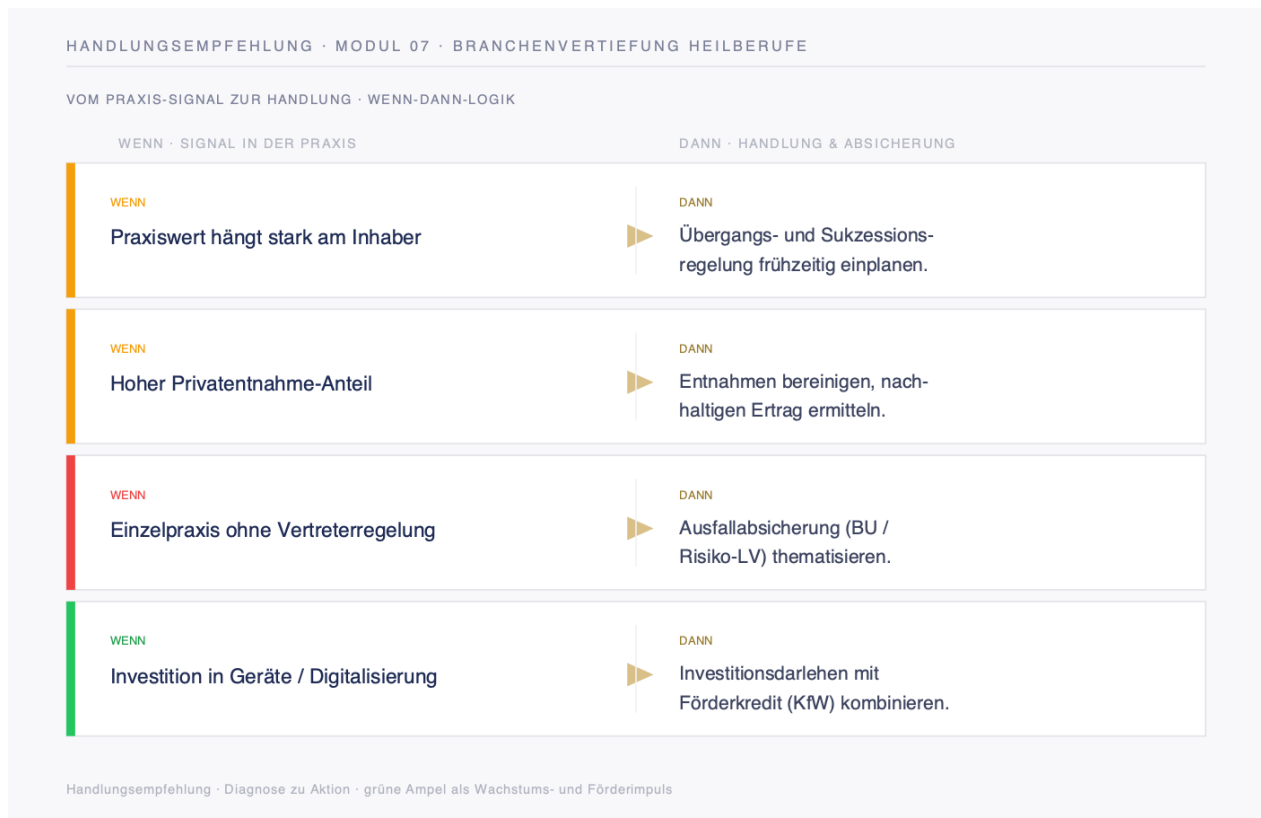
Nr.	Aufgabe	erledigt
2	EÜR-Auszüge AB-K01 vorbereitet (3 Varianten, laminiert)	
3	Taschenrechner für alle TN sichergestellt	
4	Formelkarten (DSCR, IDW S5) laminiert und bereit	
5	Fallunterlagen Sec 4 ausgedruckt	
6	Beamer/Flipchart-Technik getestet	
7	Musterlösungen griffbereit (nicht vorab austreten)	
8	Feedbackbögen und Wissenstestbögen ausgedruckt	
9	KfW-Merkblätter (037, 058/059) als optionales Handout vorbereitet	
10	Moderations-Timing verinnerlicht (kritisch: Rechenübung 10:55, Hauptfall 11:55)	

Eingesetzte Abbildungen

Die folgenden Abbildungen strukturieren den Modulverlauf und stehen als Folien (PPTX) sowie in den Teilnehmerunterlagen zur Verfügung.



PRAXISWERT-ERMITTLUNG NACH IDW S5 – SUBSTANZWERT PLUS IDEELLER PRAXISWERT (GOODWILL) NACH MODIFIZIERTER ERTRAGSWERTMETHODE



HANDLUNGSEMPFEHLUNG HEILBERUFE – WENN-DANN-KARTE: DIAGNOSE-SIGNALE UND PASSENDE BERATUNGSPULSE FÜR FREIBERUFLER-FINANZIERUNGEN

L1 – Feedbackbogen (Reaktion)

Modul M07 – Branchenvertiefung Heilberufe | Bitte nach dem Seminar ausfüllen

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen auf einer Skala von 1 (stimme gar nicht zu) bis 5 (stimme voll zu).

Nr.	Aussage	1	2	3	4	5
1	Die Seminari nhalte sind für meinen Berat ungsalltag mit Heilberufe-Ku nden direkt relevant.					

Nr.	Aussage	1	2	3	4	5
2	Das Modul hat mir neue Analysewerkzeuge gegeben, die ich sofort einsetzen kann.					
3	Die Rechenübung zur IDW-S5-Goodwill-Berechnung hat mir geholfen, die Methode zu verstehen.					
4	Die Fallstudie war realistisch und praxisnah.					
5	Das Tempo des Seminars war angemessen.					
6	Der Trainer hat die Inhalte verständlich und kompetent vermittelt.					
7	Die Seminarunterlagen (Arbeitsblätter, Formelkarte, Checkliste) sind für den späteren Gebrauch hilfreich.					
8	Ich fühle mich nach dem Seminar sicherer im Gespräch mit Heilberufekunden.					
9	Ich würde dieses Modul Kollegen weit empfehlen.					

Nr.	Aussage	1	2	3	4	5
10	Das Seminar hat meine Erwartungen insgesamt erfüllt.					

Was hat Ihnen besonders gut gefallen?

Was sollte verbessert werden?

Gesamtnote (1 = sehr gut, 6 = ungenügend): _____

L2 – Wissenstest (Lernen)

Modul M07 – Wissenstest | Bitte kreuzen Sie die richtige Antwort an.

Frage 1: Was ist das entscheidende Merkmal eines Freien Berufs gemäß § 18 EStG?

- a) Der Freie Beruf ist immer steuerfrei.
- b) Die Tätigkeit basiert auf persönlicher Berufsqualifikation und wird eigenverantwortlich und fachlich unabhängig ausgeübt.
- c) Freie Berufe sind Pflichtmitglieder der IHK.
- d) Freie Berufe müssen immer eine Bilanz erstellen.

Frage 2: Warum ist das Zufluss-/Abflussprinzip der EÜR für die Kreditanalyse relevant?

- a) Es macht die EÜR einfacher lesbar als eine Bilanz.
- b) Einnahmen und Ausgaben werden im Jahr des Zahlungsflusses erfasst – KV-Abrechnungsverzögerungen können Ertragseinbrüche vortäuschen, die keine echte Ertragsschwäche darstellen.
- c) Das Zufluss-/Abflussprinzip verhindert Rückstellungen und macht die EÜR damit risikofrei.
- d) In der EÜR werden alle Steuern automatisch berücksichtigt.

Frage 3: Welchen Zweck hat der Abzug des Unternehmerlohns bei der IDW-S5-Goodwill-Berechnung?

- a) Den Steueraufwand des Arztes zu berücksichtigen.
- b) Den nachhaltigen Praxisüberschuss zu ermitteln, den ein neuer Inhaber nach seiner eigenen Vergütung erzielen kann.
- c) Den Substanzwert der Praxis zu bestimmen.
- d) Die Praxis mit anderen Unternehmen vergleichbar zu machen.

Frage 4: Ein Arzt hat einen Ø-Jahresüberschuss von 180.000 EUR. Der arzt spezifische Unternehmerlohn beträgt 90.000 EUR, der Risikoabschlag 25 %, der Kapitalisierungsfaktor 2,5. Wie hoch ist der Goodwill-Wert?

- a) 168.750 EUR
- b) 225.000 EUR
- c) 337.500 EUR
- d) 450.000 EUR

Frage 5: Warum erscheinen Regressforderungen von Krankenkassen nicht in der EÜR des Arztes?

- a) Krankenkassen können keine Regressforderungen stellen.
- b) Regressforderungen werden erst im Jahr der tatsächlichen Zahlung erfasst; da sie oft rückwirkend entstehen, sind sie zum Analysezeitpunkt nicht sichtbar.
- c) Regressforderungen werden automatisch von der KV abgeglichen.
- d) In der EÜR erscheinen keine Ausgaben, nur Einnahmen.

Frage 6: Was unterscheidet das kassenärztliche Regelleistungsvolumen (RLV) von einer normalen Umsatzplanung?

- a) Das RLV garantiert dem Arzt ein fixes Jahreseinkommen.
- b) Das RLV begrenzt die abrechnungsfähige Leistungsmenge je Quartal – Mehrleistungen werden mit einem abgestaffelten Punktwert vergütet oder fallen ganz aus.
- c) Das RLV gilt nur für Fachärzte, nicht für Hausärzte.
- d) Das RLV wird monatlich neu festgesetzt.

Frage 7: Warum ist der Goodwill einer Arztpraxis nur eingeschränkt beleihbar?

- a) Weil Ärzte grundsätzlich schlechte Kreditnehmer sind.
- b) Weil der Goodwill an die Person des Inhabers gebunden ist und nicht auf einen Dritten übertragbar ist.
- c) Weil die BelWertV den Goodwill explizit ausschließt.
- d) Weil IDW S5 eine Bankfinanzierung des Goodwills nicht erlaubt.

Frage 8: Welche Sicherheit ist bei einer Goodwill-Finanzierung für eine Praxisübernahme Standard?

- a) Grundschild auf die Praxisräume.
- b) Abtretung der KV-Abrechnungsansprüche.
- c) Risikolebensversicherung des neuen Inhabers in Höhe des Kreditvolumens, abgetreten an die Bank.
- d) Bürgschaft der Kassenärztlichen Vereinigung.

MUSTERLÖSUNG WISSENSTEST (TRAINER-VERSION)

Trainer-Hinweis: Diese Musterlösung erst nach Abgabe der Testbögen ausgeben.

Frage	Richtige Antwort	Begründung
1	b	§ 18 Abs. 1 EStG: eigenverantwortlich, fachlich unabhängig, auf persönlicher Qualifikation basierend ^{Q142}
2	b	Zufluss-/Abflussprinzip: Kassenabrechnung Q1 fließt erst im Mai zu → EÜR spiegelt nicht Periode der Leistungserbringung ^{Q030}
3	b	Neuer Inhaber muss sich selbst vergüten; nur Überschuss nach Unternehmerlohn ist nachhaltig erzielbar (IDW S5 ^{Q146})
4	a	$(180.000 - 90.000) \times 0,75 \times 2,5 = 67.500 \times 2,5 = 168.750 \text{ EUR}$
5	b	EÜR: Zufluss-/Abflussprinzip – Regresse erscheinen erst bei tatsächlicher Zahlung; keine Rückstellungsbildung möglich ^{Q030}
6	b	RLV = quartalsbezogenes Budget; Mehrleistungen werden abgestaffelt oder nicht vergütet (KBV, 2024 ^{Q143})
7	b	Personengebundene Zulassung – erlischt bei Tod/Berufsunfähigkeit/Ruhesetzung; nicht auf Dritte übertragbar ^{Q146}
8	c	Risikolebensversicherung als Mindest-Absicherung für personengebundenen Goodwill – Standard in der Praxisfinanzierung

Auswertung:

- 7–8 richtig: Sehr gut – Lernziele M07 vollständig erreicht

- 5–6 richtig: Gut – einzelne Aspekte nochmals vertiefen
- 3–4 richtig: Ausreichend – Selbststudium Sec 5 empfohlen
- ≤ 2 richtig: Gespräch mit Führungskraft empfohlen

L3 – Beobachtungsbogen (Verhalten durch Führungskraft)

Modul M07 – Transferbeobachtung | Beobachtungszeitraum: 4–6 Wochen nach Seminar

Mitarbeiter/in: _____

Beobachter/in (Führungskraft): _____

Beobachtungszeitraum: _____

Nr.	Beobachtbares Verhalten	nicht beobachtet	teilweise	sicher
1	Erkennt eigenständig, ob ein Kunde ein Freier Beruf (§ 18 EStG) oder ein Gewerbebetrieb ist, und zieht die richtigen Schlüsse für Buchführungspflicht und Analysemethode.			
2	Analysiert eine EÜR korrekt auf Schulden dienstfähigkeit (DSCR-Berechnung inkl. Privatsteuern und -entnahmen) und benennt die spezifischen Analysefallen (Zufluss-/Abflussprinzip, fehlende Rückstellungen).			
3	Erläutert die IDW-S5-Bewertungslogik (Substanzwert + Goodwill) bei Praxisübernahmen und kann Finanzierungsvolumen plausibilisieren.			

Nr.	Beobachtbares Verhalten	nicht beobachtet	teilweise	sicher
4	Benennt beim Kundengespräch aktiv die KV-bedingte Liquiditätslücke und empfiehlt eine passende Kontokorrentlösung.			
5	Identifiziert Zulassungs- und Regressrisiken im Kundengespräch und thematisiert Absicherungsoptionen (Risikolebensversicherung, R+V BU).			
6	Erkennt bei älteren Heilberufe-Kunden (55+) proaktiv das Nachfolgethema und leitet ein strukturiertes Gespräch zur Praxisabgabe ein.			
7	Bindet Verbundpartner aktiv ein: KfW-Durchleitung bei Finanzierungen ab 50.000 EUR, Union Investment bei Anlage des Veräußerungserlöses.			
8	Fragt bei Praxisfinanzierungen die vollständigen MaRisk-Unterlagen an (EÜR der letzten 3 Jahre, aktueller Steuerbescheid, Gesellschaftsvertrag falls vorhanden).			

Gesamteinschätzung:

Empfehlungen für die weitere Entwicklung:

Datum / Unterschrift Führungskraft: _____

Grundlage: Kirkpatrick, D. L. (1994). *Evaluating Training Programs: The Four Levels*. Berrett-Koehler Publishers. ^{Q006}

ABSCHNITT

Anhang A: Musterlösungen & Trainer-Hinweise

Diese Inhalte gehören zu den Arbeitsblättern der Teilnehmerunterlagen (Sektion 4), werden dort aber herausgefiltert – sie stehen nur im Trainerhandbuch zur Verfügung.

MUSTERLÖSUNG (TRAINER-REFERENZ)

Aufgabe 1 – IDW S5:

Ø Jahresüberschuss: 303.333 EUR

./ . Unternehmerlohn: 130.000 EUR

= Ertrag vor Risiko: 173.333 EUR

./ . Risikoabschlag 25 %: - 43.333 EUR

= Nachhaltiger Jahresertrag: 130.000 EUR

× Kapitalisierungsfaktor 3,0:

= Goodwill (rechnerisch): 390.000 EUR

Der vereinbarte Goodwill von 220.000 EUR liegt **deutlich unter** dem rechnerischen Wert (Differenz: 170.000 EUR). Die Übernahme erscheint aus Käuferperspektive günstig bewertet.

Trainer-Hinweis – Vertiefungsfragen zum Gap: Dieser Unterschied von 170.000 EUR ist erklärungsbedürftig. Regen Sie folgende Diskussion an:

1. Warum akzeptiert Dr. Schmidt einen Goodwill von nur 220.000 EUR statt der rechnerischen 390.000 EUR? Mögliche Antworten: Zeitdruck beim Verkäufer (gesundheitliche Gründe), begrenzte Zahl qualifizierter Käufer in der Region, Patientenstamm-Risiko durch hohen Anteil an Stammkunden älterer Patienten, persönliche Sympathie für den Nachfolger.

2. Ist der niedrige Kaufpreis für die Bank ein Signal oder ein Vorteil? Ein Käufer, der günstig einkauft, hat einen besseren DSCR – aber: Warum wird so günstig verkauft? Hat Dr. Schmidt Informationen, die Dr. Mayer (und die Bank) nicht haben? → Asymmetrische Information ist das zentrale Risiko.

3. Was sollte die Bank zusätzlich prüfen? Laufende Regressverfahren, Abrechnungsauffälligkeiten bei der KV, Patientenstamm-Altersstruktur (wie viele Patienten sind unter 60 und bleiben der Praxis erhalten?), lokale Wettbewerbssituation (neues MVZ in der Nähe?).

Fazit: Der günstige Kaufpreis ist aus DSCR-Sicht attraktiv – rechtfertigt aber intensivere Due Diligence, nicht weniger.

Aufgabe 2 – DSCR:

$380.000 \text{ EUR} / 10 \text{ Jahre} = 38.000 \text{ EUR Tilgung p.a.}$

Zinsen Anfangsjahr: $380.000 \times 5,5 \% = 20.900 \text{ EUR}$

Zinsen Endjahr: $38.000 \times 5,5 \% = 2.090 \text{ EUR}$

Ø Zinsen: $(20.900 + 2.090) / 2 = 11.495 \text{ EUR p.a.}$

Kapitaldienst gesamt: $38.000 + 11.495 = 49.495 \text{ EUR p.a.}$

DSCR: $75.000 / 49.495 = 1,52$

Trainer-Hinweis – Kritische Diskussion: DSCR 1,52 liegt rechnerisch über der Mindestanforderung (1,20) – aber ist er bei diesem Risikoniveau wirklich ausreichend? Folgende Argumente sprechen dafür, ihn kritisch zu hinterfragen:

1. Anlaufisiko: Die 65 %-Patientenübernahme ist eine Prognose, kein gesicherter Wert. Historisch werden in den ersten 12 Monaten nach Übernahme teils nur 50–60 % erreicht. Sinkt die Patientenquote auf 55 %, bricht der Cashflow auf ca. 55.000 EUR – DSCR dann unter 1,20.

2. Kein Puffer für unvorhergesehene Ausgaben: Bei einer einzigen größeren Reparatur oder einem KV-Regressverfahren fehlt der Puffer.

3. Empfehlung: Tilgungsfreie Anlaufzeit (12 Monate nur Zinsen: 11.495 EUR p.a.) deutlich beantragen – reduziert den Kapitaldienst im ersten Jahr auf ca. 23 % des freien Cashflows und schafft echten Sicherheitspuffer.

→ Fazit: Formell tragfähig, aber am unteren Rand. Tilgungsfreiheit im ersten Jahr ist keine Kulanzfrage, sondern risikoadäquate Strukturierung.

Aufgabe 3 – Sicherheiten:

ETW: $(290.000 - 85.000) \times 60 \% = 123.000 \text{ EUR}$

LV: 42.000 EUR

Praxiseinrichtung: $100.000 \times 35 \% = 35.000 \text{ EUR}$

Sicherheitenwert gesamt: 200.000 EUR

Kreditbetrag: 380.000 EUR

Deckungsquote: 53 % → Lücke: 180.000 EUR

→ Lösungsansatz: Bürgschaft Ehepartner + Abtretung KV-Forderungen +
Risikolebensversicherung (P07-006)
